

LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR: LESIONES DEL ANTEBRAZO

A. Roces Fernández, G. Alonso Claro, R. Marcos Mesa.

FRACTURAS DIAFISARIAS DE CÚBITO Y RADIO

Mecanismo lesional: directo tras un accidente o traumatismo o indirecto tras una caída desde altura con el brazo en hiperextensión. Son más frecuentes en los niños.

Exploración física: tumefacción y deformidad en antebrazo. Es rara la lesión neurológica. Vigilar que no aparezca un síndrome compartimental.

Pruebas complementarias: Radiografía antebrazo anteroposterior y lateral.

Tratamiento: la mayoría son desplazadas, por lo que precisan tratamiento quirúrgico.

En caso de que no estén desplazadas se puede optar por un tratamiento conservador mediante un yeso braquiopalmar cerrado o férula si existe mucha tumefacción.



fractura diafisaria de cúbito y radi



fractura diafisaria de cúbito y radio

FRACTURA AISLADA DIAFISARIA DEL CÚBITO

Mecanismo lesional: por traumatismo directo, “fractura del bastonazo”.

Exploración física: deformidad y tumefacción en borde cubital del antebrazo.

IMPORTANTE

- Explorar el codo para asegurarse de que es una lesión aislada.

Pruebas complementarias: radiografía antebrazo anteroposterior y lateral.

Tratamiento: si no está desplazada y presenta una angulación $<10^\circ$ tratamiento conservador mediante yeso braquiopalmar. Si desplazada o angulación $>10^\circ$ tratamiento quirúrgico.

FRACTURA –LUXACIÓN DE MONTEGGIA

Fractura de tercio proximal del cúbito + luxación de la cabeza del radio.

Exploración física: hemartros en codo asociado a la fractura del cúbito. Dolor, deformidad y limitación funcional tanto a la flexo-extensión del codo como a la prono-supinación. Es frecuente la afectación del nervio interóseo posterior (imposibilidad para extender los dedos, pero sí la muñeca).

Pruebas complementarias: radiografía de antebrazo y codo anteroposterior y lateral.

Tratamiento: quirúrgico.



Fractura- luxación de Monteggia (fractura cúbito proximal + luxación cabeza radial)

FRACTURA-LUXACIÓN DE GALEAZZI

Fractura tercio medio-distal del radio + luxación de la radiocubital distal.

Exploración física: deformidad dolor y limitación funcional en antebrazo y muñeca, se palpa muy bien la cabeza cubital, que se reduce fácilmente.

Pruebas complementarias: radiografía antebrazo y muñeca anteroposterior y lateral.

Tratamiento: quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- Mc Rae. Ortopedia y fracturas de bolsillo. (Temas 19, 20 y 21)
- Campbell. Cirugía ortopédica. Tomo 6. Fracturas y luxaciones. (Capítulo 54)
- Rockwood & green's. Fracturas en el adulto. (Sección II, temas 21 – 30)